

Bronquiolitis obliterante posinfecciosa

Bibliográfica 2024 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David

“Bronquiolitis obliterante posinfecciosa” SAP 2018

La bronquiolitis obliterante (BO) es una enfermedad respiratoria obstructiva crónica que se caracteriza por la obliteración y/o destrucción de la pequeña vía aérea. Esta lesión es producto de la reacción inflamatoria secundaria a una lesión de la vía aérea debida a diferentes agentes (es más frecuente observarla secundaria a una lesión viral grave). En otros países, se observa con mayor frecuencia secundaria al trasplante de medula ósea y al trasplante pulmonar.

Fisiopatología

La BO se caracteriza por la oclusión parcial o total del lumen de los bronquiolos respiratorios y terminales por tejido inflamatorio y fibrosis.

Categorías

- BO proliferativa, caracterizada por la obstrucción del lumen de la pequeña vía aérea por pólipos constituidos por tejido de granulación. En los casos en que el tejido de granulación se extiende a los alvéolos, la lesión se denomina BO con neumonía organizada (BOOP, por sus siglas en inglés).
- BO constrictiva, se caracteriza por fibrosis peribronquiolar con diferentes grados de estrechamiento del lumen.

Etiología

- Adenovirus: el serotipo 7h, fue descrito como uno de los de mayor virulencia, pero otros como el serotipo 3, 5, y 21, pueden también causar BO.
- *Mycoplasma pneumoniae*
- Virus del sarampión

El desarrollo de BO es excepcional en infecciones por:

- VSR
- Influenza

Esta enfermedad se desarrolla a temprana edad, con mayor frecuencia, antes de los dos años de vida. Inicialmente, los pacientes comienzan con síntomas que no difieren de una bronquiolitis típica. La evolución suele ser tórpida con requerimientos prolongados de oxigenoterapia.

Por esta razón, un paciente con infección por adenovirus que, luego de 3 semanas de evolución, no mejora podría estar desarrollando BO.

Imágenes

- Radiografías de tórax

No son específicas; muestran atrapamiento aéreo, atelectasias, engrosamiento peribronquial y áreas sugestivas de bronquiectasias.

- TAC

Áreas con patrón en mosaico. Pueden deberse a atrapamiento aéreo y a cortocircuito vascular desde las zonas hipoventiladas a áreas normales o sobreventiladas. La perfusión está disminuida en áreas de atenuación del parénquima debido a la vasoconstricción por hipoxia tisular. Otros signos tomográficos incluye atrapamiento aéreo. También es frecuente observar bronquiectasias, engrosamiento peribronquial y atelectasias.

Espiremetría en el niño mayor

Se caracteriza por un patrón obstructivo de moderado a grave, que, en la mayoría de los casos, no responde a la administración de broncodilatadores

Biopsia pulmonar

Constituye el estándar de oro para el diagnóstico de BO, pero debido a su morbilidad y mortalidad y a que se encuentra limitado por la distribución en parches del daño pulmonar, solo

se realiza en aquellos pacientes en los cuales la duda diagnóstica persiste luego de haber realizado todos los procedimientos diagnósticos antes descritos.

Puntaje clínico-radiológico para el diagnóstico

Se considera positivo un valor ≥ 7

- Historia de bronquiolitis y/o neumonía grave en el niño menor de 2 años, previamente sano con posterior obstrucción bronquial crónica sin períodos libres de enfermedad: 4
- Infección por adenovirus: 3
- TAC con patrón en mosaico: 4

Otros antecedentes a tener en cuenta:

- Función pulmonar con obstrucción grave y fija de la vía aérea.
- Exclusión de otras enfermedades pulmonares crónicas.

Diagnósticos diferenciales

1° hay que descartar otras causas de enfermedad pulmonar crónica. Según el cuadro clínico y la historia de cada paciente, se investiga:

- Inmunodeficiencias: es el más importante a estudiar, es frecuente observa la asociación de BO e inmunodeficiencias.
- Fibrosis quística
- Síndrome aspirativo
- Fístula traqueoesofágica
- Displasia broncopulmonar
- Disquinesia ciliar primaria
- Déficit de surfactante
- Cardiopatías congénitas
- Tuberculosis

Tratamiento

Supresión de la respuesta inflamatoria: no se ha podido demostrar la utilidad de los tratamientos antiinflamatorios, como los corticosteroides, macrólidos, hydroxyl-chloroquina, bloqueadores del factor de necrosis tumoral alfa, entre otros;

Indicadores de reagudización respiratoria

- Aumento de las secreciones
- Cambio de color y consistencia
- Mayor dificultad respiratoria
- Astenia
- Disminución de la SaO₂

Tratamiento precoz:

- Antibióticos: estará guiado por los estudios bacteriológicos previos de esputo del paciente. En su defecto, el tratamiento empírico inicial deberá cubrir: *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pneumoniae* y *Moraxella catarrhalis*. En niños mayores y en aquellos que no respondieron a la primera línea de tratamiento, se deberá considerar realizar el tratamiento contra *Pseudomonas aeruginosa*.
- Intensificar la kinesiólogía respiratoria
- Broncodilatadores

Complicaciones

- Reflujo gastroesofágico: es una complicación frecuente (54%)
- Hipertensión pulmonar: es una complicación Infrecuente
- Aspiración pulmonar
- Colonización con *Pseudomonas aeruginosa* u otro germen resistente
- Micosis
- Hipoxemia nocturna
- Desnutrición

- En forma excepcional, algunos pacientes desarrollan deformidad torácica (con mayor frecuencia, pectus carinatum asimétrico), que podría ser el resultado de una combinación de desmineralización ósea y grave atrapamiento aéreo. Puede ser clínicamente deletéreo debido a la interferencia con la mecánica respiratoria.

Prevención de sobreinfecciones

Supervisión del cumplimiento de inmunizaciones

Educación del niño y la familia para evitar riesgos innecesarios de contagio de enfermedades infecciosas respiratorias.